ESTUDO DE MERCADO · BRASIL 2026

Dependência química no Brasil

Portal de serviços + central humana de orientação

atomdigital.com.br

SUMÁRIO EXECUTIVO

Vale **testar** o modelo. Ainda não é hora de acelerar.

Existe necessidade social relevante, mas ela não equivale a mercado pagante. O diferencial é reduzir a dificuldade de escolher um serviço, preservando a autonomia da pessoa e o acesso ao SUS.

- → **Portal + central humana** conectando pessoas e famílias a prestadores compatíveis, com cobertura nacional progressiva;
- → **O ativo é informação** comparável e verificável sobre o cuidado disponível;
- → **Receita B2B por assinatura**, sem comissão por paciente encaminhado;
- → **Aquisição sem Google Ads**: a categoria não é elegível no Brasil;
- → **Investimento por etapas**, liberado a cada marco de evidência.

Orçamento de validação: R$ 156 mil em 90 dias.

O PROBLEMA EM NÚMEROS

Necessidade relevante não é o mesmo que **mercado pagante**

11,5%

da população com 14 anos ou mais apresenta transtorno por uso de álcool

LENAD III · REF. 2023 · IC95% 10,2–13,0%

499

CAPS AD, AD III e AD IV, a porta de entrada pública especializada

MINISTÉRIO DA SAÚDE · DEZ/2024

1.950

comunidades terapêuticas estimadas, referência histórica do setor

IPEA · LEVANTAMENTO 2017

Os três medem populações diferentes: confirmam o problema, mas não somam um TAM financeiro.

DINÂMICA DO SETOR

A rede pública cresce devagar e de forma constante

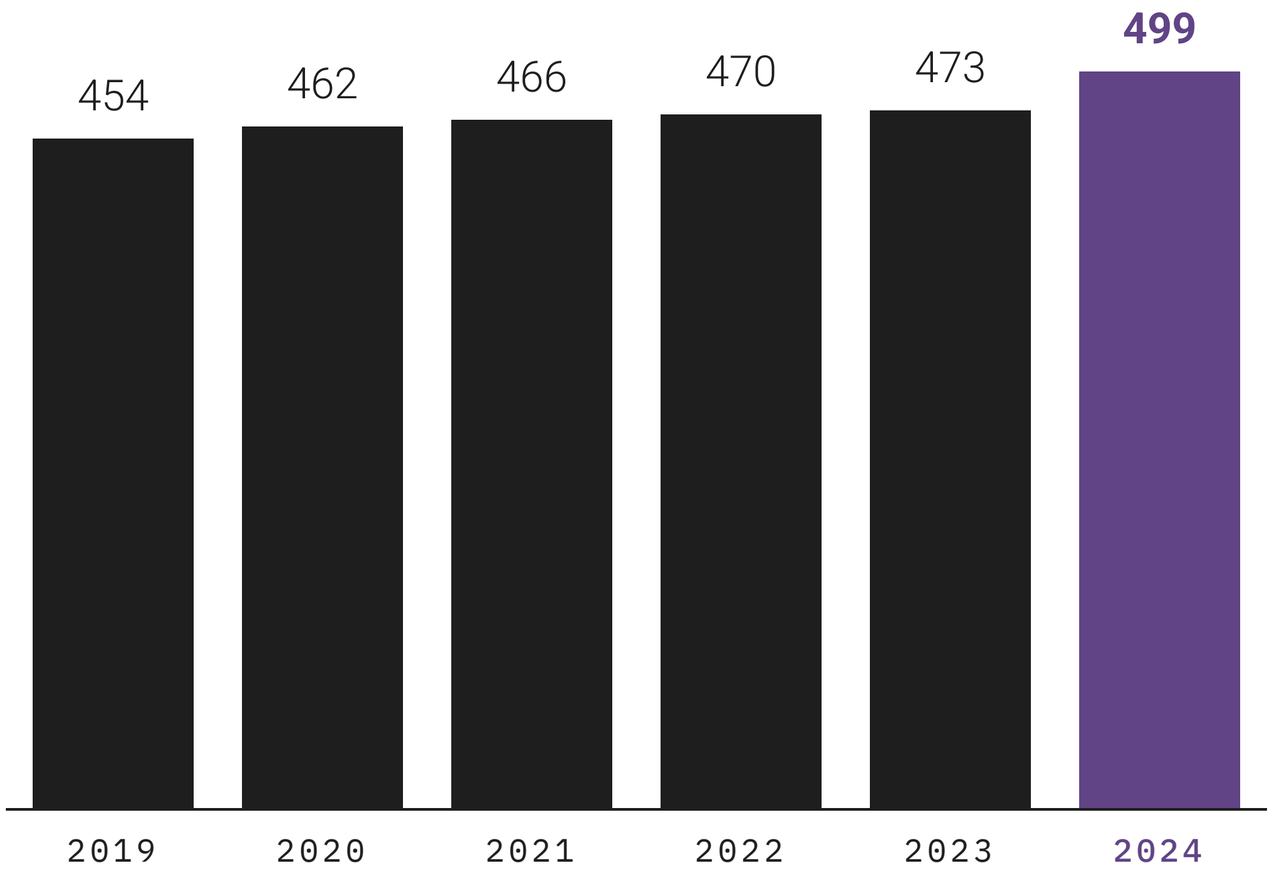
+ 9,91%

CAPS AD, AD III e AD IV entre 2019 e 2024 · CAGR 1,91%

+ 13,54%

CAPS de todos os tipos (2.659 → 3.019) · CAGR 2,57%

CAPS AD + AD III + AD IV · DEZEMBRO DE CADA ANO



Crescimento de serviços públicos habilitados, não de faturamento privado. Fonte: Saúde Mental em Dados, ed. 13.

DEFINIÇÃO DO MERCADO

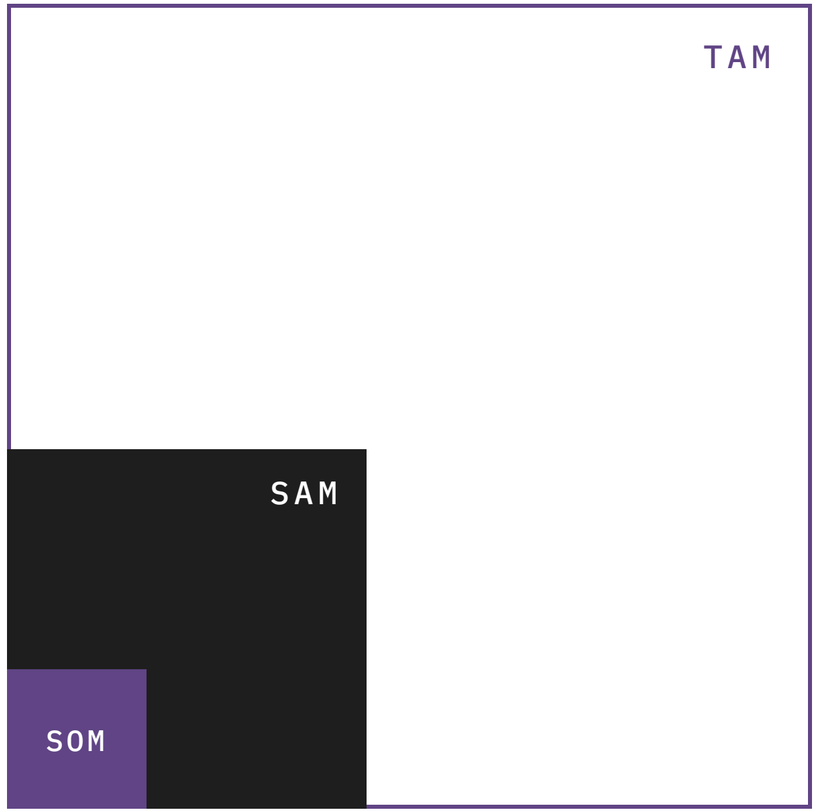
O projeto atua em **navegação e acesso**

Organizar informação, opções e o contato escolhido pela pessoa. Diagnóstico e decisão de internação ficam com profissionais habilitados, nunca com vendedor ou IA.

SEGMENTO E FUNÇÃO	LIMITE IMPORTANTE
Clínicas e hospitais Avaliação e cuidado conforme capacidade documentada	→ Internação depende de avaliação e requisitos próprios
Ambulatórios e profissionais Cuidado fora da internação	→ Não tratar ambulatório como solução inferior
Comunidades terapêuticas Acolhimento voluntário e apoio social	→ Acolhimento não é internação médica
CAPS AD e RAPS Caminho público de acesso e continuidade	→ Não vender vagas ou prioridade no SUS
Ajuda mútua e família Recursos complementares e comunitários	→ Não substitui avaliação de saúde
Portal e central Informação, opções e contato escolhido	→ Não diagnostica nem decide internação

DIMENSIONAMENTO B2B

TAM, SAM e SOM do portal: **premissas a testar**



TAM — R$ 14,4 mi /ano

1.000 unidades elegíveis × R$ 1.200/mês × 12

SAM — R$ 2,88 mi /ano

200 unidades que a operação consegue verificar e servir

SOM — R$ 432 mil /ano

30 parceiros pagantes ao fim do ano 1 · receita do ano ≈ R$ 259 mil

HIPÓTESE · 1.000 E 200 UNIDADES SÃO VARIÁVEIS DE TESTE, NÃO CENSO

ECONOMIA DO NEGÓCIO

Com 30 parceiros, a operação só **empata**

CONSERVADOR

15 parceiros × R$ 900

R$ 13.500/mês · fixos R$ 25 mil

BASE

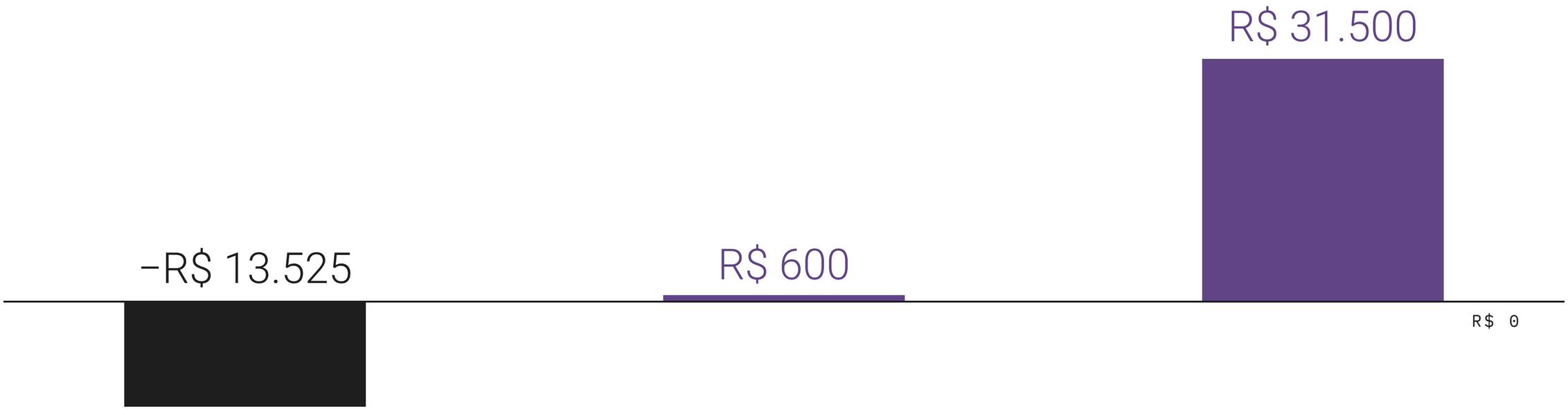
30 parceiros × R$ 1.200

R$ 36.000/mês · fixos R$ 30 mil

EXPANSÃO

60 parceiros × R$ 1.500

R$ 90.000/mês · fixos R$ 45 mil



Equilíbrio: **33 parceiros**

Equilíbrio: **30 parceiros**

Equilíbrio: **36 parceiros**

RESULTADO OPERACIONAL MENSAL = RECEITA × 85% − CUSTOS FIXOS · CENÁRIOS HIPOTÉTICOS

CONCORRÊNCIA | CANAIS | RISCOS

Paisagem digital e estratégica

CONCORRÊNCIA DIGITAL

A concorrência já vende **conveniência**

DIRETÓRIO · DIRETO

Busca Clínicas

buscaclinicasderecuperacao.com.br

Perfis locais, contato e cadastro B2B de anunciantes.

PORTAL + CENTRAL

Portal Clínicas

clinicas.grupotriunfosaude.com.br

Declara 800+ unidades; rede não auditada.

CENTRAL · DIRETO

Grupo Vida

grupovidarecuperacoes.com.br

Clínicas parceiras e contato anunciado 24h.

CONTEÚDO

Portal Dependência Química

portaldependenciaquimica.com.br

Tratamentos e WhatsApp; posicionamento a rechecar.

DIRETÓRIO PÚBLICO

Portal Acolhe

portalacolhe.com.br

Usa CNES e distingue o próprio papel.

PRESTADOR + REDE

Grupo Recanto

gruporecanto.com.br

Quatro unidades e conteúdo próprio.

PRESTADOR

Jorge Jaber

clinicajorgejaber.com.br

Ambulatório, hospital-dia e internação.

REDE DE TRATAMENTO

Vila Serena

vilaserena.com.br

Unidades e abordagem; contato descentralizado.

OFERTA + CENTRAL

Aliança pela Vida

grupoaliancapelavida.com.br

Páginas por perfil e formulário curto.

REDE PRÓPRIA

Nascente

nascenteclinicas.com.br

Benchmark de transparência por unidade.

Contorno roxo: concorrentes diretos de produto. Seleção intencional, não ranking. Tráfego e autoridade dos domínios: dado Semrush pendente.

AQUISIÇÃO

Onde a aquisição pode, e não pode, acontecer

1. **Google Ads** R$ 0
   A categoria não é elegível no Brasil, inclusive para intermediários.

2. **Perfil da Empresa** RESTRITO
   Só unidades físicas reais; geração de leads não é elegível.

3. **Meta Ads** PENDENTE
   Elegibilidade a confirmar; nenhuma verba de desempenho prometida.

4. **Conteúdo, marca e parcerias** MOTOR
   SEO, GEO/AEO, fichas verificáveis e distribuição orgânica.

ANÁLISE PESTEL

O risco está concentrado no **legal e nas plataformas**

P	E	S	T	A	L
POLÍTICO	ECONÔMICO	SOCIAL	TECNOLÓGICO	AMBIENTAL	LEGAL
20 Expansão da rede pública	20 Retenção B2B não validada	20 Estigma e confidencialidade	25 Dependência de plataformas	20 Estrutura física do parceiro	25 Distinção de modalidades
16 Supervisão do acolhimento	20 Amplitude dos preços	20 Família participa da busca	20 Atendimento automatizado	12 Distância até o cuidado	25 Comissionamento
ND Projetos de certificação	16 Central intensiva em pessoas	16 Diferenças entre públicos	16 Respostas generativas	12 Eventos extremos	25 Dados sensíveis (LGPD)

Impacto × probabilidade = 25 | 20 | 16 ou menos

Escala de gestão 1–5 × 1–5 (hipótese), não probabilidade estatística.

CINCO FORÇAS DE PORTER

Atratividade moderada, **condicionada à execução**

Substitutos	5/5	Contato direto, SUS, profissionais e fontes oficiais. O portal precisa reduzir esforço real.
Rivalidade	4/5	Portais, centrais e redes com conteúdo e contato direto. Priorizar evidência e utilidade.
Novos entrantes	4/5	Criar páginas é fácil; verificar prestadores é difícil. Cadastro confiável é a barreira.
Fornecedores	4/5	Unidades elegíveis são recurso crítico e podem atender direto. Entregar valor contínuo.
Compradores	4/5	Clínicas questionam o retorno; famílias comparam custo e acesso.

As barreiras úteis são confiança, governança e rede verificável.

SWOT

Construir confiança **antes** de alcance

S FORÇAS POTENCIAIS

- → Experiência em SEO, conteúdo e sites;
- → Capacidade de automação, CRM e mensuração;
- → Integração entre marketing e operação comercial;
- → Produção e teste internos.

W FRAQUEZAS ATUAIS

- → Rede de parceiros ainda não verificada;
- → Modelo de receita e contratos não validados;
- → Sem coorte de retenção nem CAC próprio;
- → Supervisão clínica a contratar ou confirmar.

O OPORTUNIDADES

- → Comparar modalidades distintas com clareza;
- → Explicar o custo total diante de preços incomparáveis;
- → Integrar caminhos públicos e particulares;
- → Serviços administrativos reais ao prestador.

T AMEAÇAS

- → Restrições do Google Ads e de perfis locais;
- → Risco de comissionamento e uso indevido de dados;
- → Contato direto dispensar o portal;
- → Respostas de IA reduzirem visitas.

Homologar a primeira rede e validar a assinatura antes de produzir conteúdo em escala.

PILOTO | METAS | ORÇAMENTO

Plano de 90 dias

CRONOGRAMA COM MARCOS DE DECISÃO

Seis etapas, um **relatório de decisão**

DIAS 1–15

Definir serviço, contratos, privacidade e governança; entrevistar gestores e usuários.

ENTREGA

Escopo aprovado e roteiro de pesquisa.

DIAS 16–30

Construir cadastro, homologar os primeiros serviços e desenhar a jornada.

ENTREGA

10 unidades verificadas e protótipo testado.

DIAS 31–45

Publicar o site inicial, treinar a central e iniciar distribuição orgânica.

ENTREGA

10 guias, 10 fichas e 10 páginas locais úteis.

DIAS 46–60

Medir procura, revisar o fluxo, ampliar a rede e testar assinatura.

ENTREGA

20 unidades e 3 parceiros em piloto pago.

DIAS 61–75

Cobrir lacunas regionais e de modalidade; melhorar o tempo de resposta.

ENTREGA

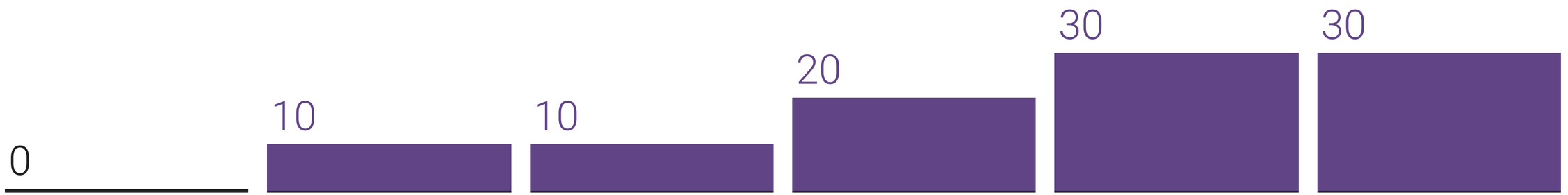
30 unidades, 20 guias e até 20 páginas locais.

DIAS 76–90

Analisar custos, retenção inicial, escolha e qualidade.

ENTREGA

Relatório de decisão de investimento.

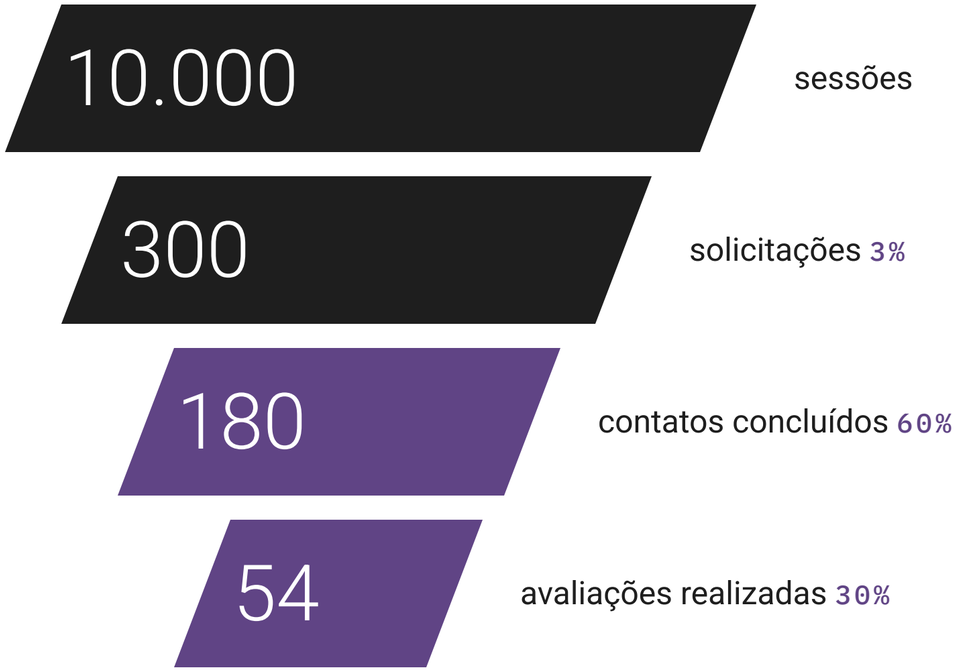


BARRAS: UNIDADES VERIFICADAS ACUMULADAS · META DE 30 EM PELO MENOS 15 UFS E NAS CINCO REGIÕES

FUNIL E INDICADORES

Medir utilidade, **nunca internações**

SENSIBILIDADE DE AQUISIÇÃO · HIPÓTESE



Percentuais não observados: o exercício mostra quantas variáveis precisam ser medidas.

METAS ATÉ O DIA 90

100	solicitações consentidas
70	orientações concluídas
30	avaliações realizadas, com autorização
≤ 15 min	resposta humana mediana, no horário anunciado

ORÇAMENTO DE VALIDAÇÃO

Liberação **por etapas**

R$ 156 mil

R$ 130 mil + reserva de 20% para 90 dias.

PRIMEIRA ETAPA

Até R$ 40 mil agora; o restante após os marcos dos primeiros 30 dias.



PROVISÕES DE PLANEJAMENTO, SEM COTAÇÃO · SEM CENTRAL 24H NACIONAL

CRITÉRIOS PARA CONTINUAR

O que precisa ser verdade aos 90 dias

- → Documentação válida de todos os parceiros publicados;
- → Nenhuma falha grave sem solução;
- → Usuários demonstrando utilidade real;
- → Pelo menos **cinco parceiros pagando** por escopo real;
- → Evidência de que a operação atinge margem com escala.

A decisão segue a qualidade das evidências, não apenas as contagens.